

Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung



**RSI SULTAN
AGUNG**

ISLAMIC TEACHING HOSPITAL

Rumah Sakit Sesuai Prinsip Syariah

SEMARANG - JAWA TENGAH

PANDUAN PRAKTIK KLINIS DOKTER UMUM

NOMOR 1152/PER/RSAL-SA/2020



Mencintai Allah, Menyayangi Sesama
Berkhidmat Menyelamatkan Umat

PERATURAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT ISLAM SULTAN AGUNG
NOMOR 1152/PER/RSI-SA/I/2020
TENTANG
PANDUAN PRAKTIK KLINIS DOKTER UMUM
DI RUMAH SAKIT ISLAM SULTAN AGUNG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM
DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT ISLAM SULTAN AGUNG

- Menimbang : a. bahwa penyusunan standar pelayanan kedokteran bertujuan untuk memberikan jaminan kepada pasien untuk memperoleh pelayanan kedokteran yang berdasarkan nilai ilmiah sesuai dengan kebutuhan medis pasien serta mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan kedokteran yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi;
- b. bahwa sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pelayanan klinis dokter umum perlu dibuat Panduan Praktik Klinis Dokter Umum sebagai acuan pelayanan klinis dokter umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Direktur Utama Rumah Sakit Islam Sultan Agung tentang Panduan Praktik Klinis Dokter Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
2. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1438/Menkes/Per/IX/2010 Tentang Standar Pelayanan Kedokteran;
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 755/Menkes/PER/IV/2011 Tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
4. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 107/DSN-MUI/IX/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah;
5. Keputusan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Nomor 12/SK/YBW-SA/II/2018 Tentang Pengangkatan dr. H. Masyhudi AM, M.Kes sebagai Direktur Utama Rumah Sakit Islam Sultan Agung Masa Bakti 2018 – 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT ISLAM SULTAN AGUNG TENTANG PANDUAN PRAKTIK KLINIS DOKTER UMUM.

Pasal 1

Panduan Praktik Klinis adalah panduan prosedur standar dalam pelayanan dan perawatan kepada pasien yang harus diketahui dan dijalankan oleh seorang dokter untuk melaksanakan kegiatan kesehatan secara optimal, professional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 2

Panduan Praktik Klinis bagi dokter di Rumah Sakit bertujuan untuk memberikan acuan bagi dokter dalam memberikan pelayanan di Rumah sakit dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.

Pasal 3

Panduan Praktik Klinis Dokter di Rumah Sakit meliputi pedoman penatalaksanaan terhadap penyakit, diambil berdasarkan kriteria:

1. Penyakit yang prevalensinya cukup tinggi;
2. Penyakit yang membutuhkan biaya tinggi; dan
3. Penyakit yang risiko tinggi.

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai panduan praktik klinis dokter umum tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Utama ini.

Pasal 4

Peraturan Direktur Utama Rumah Sakit Islam Sultan Agung ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal 12 Jumadil Awwal 1441 H
08 Januari 2020 M

DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT ISLAM SULTAN AGUNG


 **RSI SULTAN AGUNG**
ISLAMIC TEACHING HOSPITAL
Rumah Sakit Sesuai Prinsip Syariah
SEMARANG - JAWA TENGAH
Dr. H. MASYHUL AM, M.Kes.



PENYUSUN
 PANDUAN PRAKTIK KLINIS
 DOKTER UMUM

1	dr. Sri Berdi Karyati, M.Kes,	Ka SM Dokter Umum
2	dr. Retno Tri Wulandari, M.Gz.	Dokter Umum
3	dr. Fatah Yasin	Dokter Umum
4	dr. Cahyo Adji Wicaksono	Dokter Umum
5	dr. Ayu Sekar Melati	Dokter Umum
6	dr. Arina Manasikana	Dokter Umum
7	dr. Vera Provitasai	Dokter Umum
8	dr. Saras Pujowati	Dokter Umum
9	dr. Reza Rahardian	Dokter Umum
10	dr. Cholid Fathoni	Dokter Umum
11	dr. Muhammad Aziz Rosidi	Dokter Umum
12	dr. Erna Ulfiyatun Ni'amah	Dokter Umum
13	dr. Rizky Prakoso Utomo	Dokter Umum
14	dr. Sharah Aulia	Dokter Umum
15	dr. Farida Nur Aini	Dokter Umum
16	dr. Ivan Ferdianto	Dokter Umum
17	dr. Raras Hanik Rachmawati	Dokter Umum
18	dr. Yolinda Candra Arintya	Dokter Umum
19	dr. Ainul Mardliyah	Dokter Umum
20	dr. Intanrizana Baiq Yusticia	Dokter Umum
21	dr. Suryani Yulianti	Dokter Umum
22	dr. Retno Widi	Dokter Umum
23	dr. Ismoko	Dokter Umum
24	dr. Rifqi Ali Zaki	Dokter Umum
25	dr. Githae Dwi Desianti	Dokter Umum



DAFTAR ISI

halaman Judul	Error! Bookmark not defined.
Peraturan Direktur Utama	2
Penyusun	4
Daftar Isi	5
Kata Pengantar	6
Pendahuluan	7
Panduan Praktik Klinis Hipertensi Esensial.....	8
Panduan Praktik Klinis Cardiorespiratory Arrest.....	11
Panduan Praktik Klinis Angina Pectoris Stabil	14
Panduan Praktik Klinis Serangan Asma	19
Panduan Praktik Klinis Luka Bakar	21
Penutup	24



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Demi kelancaran Pelayanan Medis di Bagian Dokter Umum, maka perlu dibuat Prosedur Tetap dalam bentuk Panduan Praktik Klinis sebagai acuan dokter Umum dalam bertugas. Adanya buku ini diharapkan menjadi pedoman kerja bagi tenaga medis dan pihak terkait dalam meningkatkan pelayanan, selain itu juga dapat menjadi bahan referensi.

Pada kesempatan ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua Staf Medis atas kerjasamanya yang baik dalam menyusun buku prosedur tetap Dokter Umum ini.

Kami berharap agar keberhasilan yang telah dicapai akan memacu kita semua untuk turut menambah buku-buku ilmiah yang berguna bagi peningkatan pelayanan Dokter Umum.

Semoga keberadaan buku Panduan Praktik Klinis ini bermanfaat.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 8 Januari 2020

Penyusun



LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT ISLAM SULTAN AGUNG
NOMOR 1152/PER/RSI-SA/I/2020
TENTANG PANDUAN PRAKTIK KLINIS DOKTER
UMUM

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan medis adalah pelayanan kesehatan perorangan; lingkup pelayanan adalah segala tindakan atau perilaku yang diberikan kepada pasien dalam upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Substansi pelayanan medis adalah praktik ilmu pengetahuan dan teknologi medis yang telah ditapis secara sosio – ekonomi – budaya yang mengacu pada aspek pemerataan, mutu dan efisiensi, sehingga dapat memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat akan pelayanan medis.

Untuk menyelenggarakan pelayanan medis yang baik dalam arti efektif, efisien dan berkualitas serta merata dibutuhkan masukan berupa sumber daya manusia, fasilitas, prafasilitas, peralatan, dana sesuai dengan prosedur serta metode yang memadai.

Saat ini sektor kesehatan melengkapi peraturan perundang-undangnya dengan disahkannya Undang-undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pada bulan Oktober 2004 yang diberlakukan mulai bulan Oktober 2005. Pengaturan praktik kedokteran bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pasien, mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh dokter/dokter gigi, serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan dokter/dokter gigi.

Panduan praktik klinis (*Clinical practice guidelines*) merupakan panduan yang berupa rekomendasi untuk membantu dokter atau dokter gigi dalam memberikan pelayanan kesehatan. Panduan ini berbasis bukti (berdasarkan penelitian saat ini) dan tidak menyediakan langkah-pendekatan untuk perawatan dan pengobatan, namun memberikan informasi tentang pelayanan yang paling efektif. Dokter atau dokter gigi menggunakan panduan ini sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan mereka untuk menentukan rencana pelayanan yang tepat kepada pasien.

B. Tujuan

1. Meningkatkan mutu dan keselamatan pasien.
2. Meningkatkan mutu pelayanan pada keadaan klinis dan lingkungan tertentu
3. Mengurangi jumlah intervensi yang tidak perlu atau berbahaya
4. Memberikan opsi pengobatan terbaik dengan keuntungan maksimal
5. Memberikan opsi pengobatan dengan risiko terkecil
6. Memberikan tata laksana dengan biaya yang memadai



PANDUAN PRAKTIK KLINIS HIPERTENSI ESENSIAL																	
1	Pengertian	Kondisi terjadinya peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari ≥ 140 mmHg dan atau diastolik ≥ 90 mmHg.															
2	Anamnesis	Mulai dari tidak bergejala sampai dengan bergejala. Keluhan hipertensi antara lain: sakit/nyeri kepala, gelisah, jantung berdebar-debar, pusing, leher kaku, penglihatan kabur, dan rasa sakit di dada. Keluhan tidak spesifik antara lain tidak nyaman kepala, mudah lelah dan impotensi.															
3	Pemeriksaan Fisik	Pasien tampak sehat, dapat terlihat sakit ringan-berat. Tekanan darah meningkat (sesuai kriteria JNC VII). Nadi tidak normal. Pada pasien dengan hipertensi, wajib diperiksa status neurologis, akral, dan pemeriksaan fisik jantungnya (JVP, batas jantung, dan rochi).															
4	Pemeriksaan Penunjang	1. Urinalisis (proteinuri atau albuminuria), 2. tes gula darah, tes kolesterol (profil lipid), 3. ureum kreatinin, 4. funduskopi, 5. EKG dan foto thoraks.															
5	Kriteria Diagnosis	Klasifikasi tekanan darah berdasarkan <i>Joint National Committee VII</i> (JNC VII) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Klasifikasi</th><th>TD Sistolik</th><th>TD Diastolik</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Normal</td><td>< 120 mmHg</td><td>< 80 mmHg</td></tr> <tr> <td>Pre-Hipertensi</td><td>120-139 mmHg</td><td>80-89 mmHg</td></tr> <tr> <td>Hipertensi stage -1</td><td>140-159 mmHg</td><td>80-99 mmHg</td></tr> <tr> <td>Hipertensi stage -2</td><td>≥ 160 mmHg</td><td>≥ 100 mmHg</td></tr> </tbody> </table>	Klasifikasi	TD Sistolik	TD Diastolik	Normal	< 120 mmHg	< 80 mmHg	Pre-Hipertensi	120-139 mmHg	80-89 mmHg	Hipertensi stage -1	140-159 mmHg	80-99 mmHg	Hipertensi stage -2	≥ 160 mmHg	≥ 100 mmHg
Klasifikasi	TD Sistolik	TD Diastolik															
Normal	< 120 mmHg	< 80 mmHg															
Pre-Hipertensi	120-139 mmHg	80-89 mmHg															
Hipertensi stage -1	140-159 mmHg	80-99 mmHg															
Hipertensi stage -2	≥ 160 mmHg	≥ 100 mmHg															
6	Diagnosis Kerja	Hipertensi															
7	Diagnosis Banding	1. Proses akibat white coat hypertension. 2. Proses akibat obat. 3. Nyeri akibat tekanan intraserebral. E 4. Ensefalitis															
8	Terapi	1. Perubahan gaya hidup 2. Pemberian obat anti hipertensi merupakan pengobatan jangka panjang. Kontrol pengobatan dilakukan setiap 2 minggu atau 1 bulan untuk mengoptimalkan hasil pengobatan. Medikamentosa 1. Hipertensi tanpa <i>compelling indication</i> - Hipertensi stage1: dapat diberikan diuretik (HCT 12.5-50 mg/hari, atau pemberian penghambat ACE (captopril 3x12,5-50 mg/hari), atau nifedipin long acting 30-60 mg/hari) atau kombinasi. - Hipertensi stage2: Bila target terapi tidak tercapai setelah observasi selama 2 minggu, dapat diberikan kombinasi 2 obat,															



		biasanya golongan diuretik, tiazid dan penghambat ACE atau penyekat reseptor beta atau penghambat kalsium. c. Pemilihan anti hipertensi didasarkan ada tidaknya kontraindikasi dari masing-masing antihipertensi diatas. Sebaiknya pilih obat hipertensi yang diminum sekali sehari atau maksimum 2 kali sehari. 1) Bila target tidak tercapai maka dilakukan optimalisasi dosis atau ditambahkan obat lain sampai target tekanan darah tercapai. 2) Kondisi khusus lain a) Lanjut Usia (1) Diuretik(tiazid) mulai dosis rendah 12,5 mg/hari. (2) Obat hipertensi lain mempertimbangkan penyakit penyerta. b) Kehamilan 1) Golongan metildopa, penyekat reseptor β, antagonis kalsium, vasodilator. 2) Penghambat ACE dan antagonis reseptor AII tidak boleh digunakan selama kehamilan.																																																							
		<table><tr><th rowspan="2">Indikasi khusus</th><th colspan="6">Obat yang direkomendasikan</th></tr><tr><th>Diuretik</th><th>Penyekat beta (BB)</th><th>Penghambat ACE (ACEI)</th><th>Antagonis reseptor AII (ARB)</th><th>Penghambat kanal kalsium (CCB)</th><th>Antagonis aldosteron</th></tr><tr><td>Gagal jantung</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td></td><td>√</td></tr><tr><td>Paska infark miokard akut</td><td></td><td>√</td><td>√</td><td></td><td></td><td>√</td></tr><tr><td>Risiko tinggi penyakit: coroner</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td></td><td>√</td><td></td></tr><tr><td>DM</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td></td></tr><tr><td>Penyakit: ginjal kronik</td><td></td><td></td><td>√</td><td>√</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pencegahan stroke berulang</td><td>√</td><td></td><td>√</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Indikasi khusus	Obat yang direkomendasikan						Diuretik	Penyekat beta (BB)	Penghambat ACE (ACEI)	Antagonis reseptor AII (ARB)	Penghambat kanal kalsium (CCB)	Antagonis aldosteron	Gagal jantung	√	√	√	√		√	Paska infark miokard akut		√	√			√	Risiko tinggi penyakit: coroner	√	√	√		√		DM	√	√	√	√	√		Penyakit: ginjal kronik			√	√			Pencegahan stroke berulang	√		√			
Indikasi khusus	Obat yang direkomendasikan																																																								
	Diuretik	Penyekat beta (BB)	Penghambat ACE (ACEI)	Antagonis reseptor AII (ARB)	Penghambat kanal kalsium (CCB)	Antagonis aldosteron																																																			
Gagal jantung	√	√	√	√		√																																																			
Paska infark miokard akut		√	√			√																																																			
Risiko tinggi penyakit: coroner	√	√	√		√																																																				
DM	√	√	√	√	√																																																				
Penyakit: ginjal kronik			√	√																																																					
Pencegahan stroke berulang	√		√																																																						
9	Edukasi	1. Edukasi tentang cara minum obat di rumah, perbedaan antara obat-obatan yang harus diminum untuk jangka panjang (misalnya untuk mengontrol tekanan darah) dan pemakaian jangka pendek untuk menghilangkan gejala (misalnya untuk mengatasi mengi), cara kerja tiap-tiap obat, dosis yang digunakan untuk tiap obat dan berapa kali minum sehari. 2. Pemberian obat anti hipertensi merupakan pengobatan jangka panjang. Kontrol pengobatan dilakukan setiap 2 minggu atau 1 bulan untuk mengoptimalkan hasil pengobatan. 3. Penjelasan penting lainnya adalah tentang pentingnya menjaga kecukupan pasokan obat-obatan dan minum obat teratur seperti yang disarankan meskipun tak ada gejala. 4. Individu dan keluarga perlu diinformasikan juga agar melakukan																																																							



		pengukuran kadar gula darah, tekanan darah dan periksa urin secara teratur. Pemeriksaan komplikasi hipertensi dilakukan setiap 6 bulan atau minimal 1 tahun sekali.																			
10	Prognosis	Prognosis umumnya bonam apabila terkontrol.																			
11	Kompetensi	Semua dokter umum																			
12	Indikator Medis	<table><tr><td>No</td><td>Konten</td><td>ya</td><td>tidak</td><td>keterangan</td></tr><tr><td>1.</td><td>Penegakan diagnosis</td><td>√</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.</td><td>Terapi</td><td>√</td><td></td><td></td></tr></table>					No	Konten	ya	tidak	keterangan	1.	Penegakan diagnosis	√			2.	Terapi	√		
No	Konten	ya	tidak	keterangan																	
1.	Penegakan diagnosis	√																			
2.	Terapi	√																			
13	Kriteria Pasien Pulang Rawat Inap	1. Jika Kondisi Baik 2. Hemodinamik Stabil																			
14	Daftar Pustaka	Direktorat Penyakit Tidak Menular. Buku Pedoman Pengendalian Hipertensi. Jakarta : Kementerian Kesehatan RI. 2013. (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2013)																			



PANDUAN PRAKTIK KLINIS CARDIORESPIRATORY ARREST		
1	Pengertian	Cardiorespiratory Arrest (CRA) adalah kondisi kegawatdaruratan karena berhentinya aktivitas jantung paru secara mendadak yang mengakibatkan kegagalan sistem sirkulasi. Hal ini disebabkan oleh malfungsi mekanik jantung paru atau elektrik jantung. Kondisi yang mendadak dan berat ini mengakibatkan kerusakan organ. Henti jantung adalah konsekuensi dari aktivitas otot jantung yang tidak terkoordinasi. Dengan EKG, ditunjukkan dalam bentuk Ventricular Fibrillation (VF). Satu menit dalam keadaan persisten VF, aliran darah koroner menurun hingga tidak ada sama sekali. Dalam 4 menit, aliran darah katoris tidak ada sehingga menimbulkan kerusakan neurologi secara permanen. Jenis henti jantung 1. Pulseless Electrical Activity (PEA) 2. Takikardia Ventrikel 3. Fibrilasi Ventrikel 4. Asistole
2	Anamnesis	Pasien dibawa karena pingsan mendadak dengan henti jantung dan paru. Sebelumnya, dapat ditandai dengan fase prodromal berupa nyeri dada, sesak, berdebar dan lemah. Hal yang perlu ditanyakan kepada keluarga pasien adalah untuk mencari penyebab terjadinya CRA antara lain oleh: 1. 5 H (hipovolemia, hipoksia, hidrogen ion atau asidosis, hiper atau hipokalemia dan hipotermia). 2. 5 T (tension pneumothorax, tamponade, trombosis koroner, dan thrombosis pulmoner), tersedak, tenggelam, gagal jantung akut, emboli paru, atau keracunan karbon monoksida.
3	Pemeriksaan Fisik	1. Pada pemeriksaan tanda vital ditemukan: 2. Pasien tidak sadar 3. Tidak ada nafas 4. Tidak teraba denyut nadi di arteri-arteri besar (karotis dan femoralis).
4	Pemeriksaan Penunjang	Gambaran EKG biasanya menunjukkan gambaran VF (Ventricular Fibrillation). Selain itu dapat pula terjadi asistol, yang survival rate-nya lebih rendah daripada VF.
5	Kriteria Diagnosis	Diagnosis ditegakkan berdasarkan pemeriksaan fisik sedangkan anamnesis berguna untuk mengidentifikasi penyebabnya.
6	Diagnosis Kerja	Cardiorespiratory Arrest
7	Diagnosis Banding	-

8	Terapi	Adult Cardiac Arrest Shout for Help/Activate Emergency Response 1 Start CPR • Give oxygen • Attach monitor/defibrillator 2 Rhythm shockable? Yes No 3 Shock 4 CPR 2 min • IV/IO access 5 Rhythm shockable? Yes No 6 CPR 2 min • Epinephrine every 3-5 min • Consider advanced airway, capnography 7 Rhythm shockable? Yes No 8 CPR 2 min • Amiodarone • Treat reversible causes 9 Asystole/PEA 10 CPR 2 min • IV/IO access • Epinephrine every 3-5 min • Consider advanced airway, capnography 11 Rhythm shockable? Yes No 12 CPR 2 min • Treat reversible causes 13 Rhythm shockable? Yes No 14 Go to 5 or 7 15 If no signs of return of spontaneous circulation (ROSC), go to 10 or 11 16 If ROSC, go to Post-Cardiac Arrest Care © 2010 American Heart Association CPR Quality • Push hard (≥2 inches [5 cm]) and fast (≥100/min) and allow complete chest recoil • Minimize interruptions in compressions • Avoid excessive ventilation • Rotate compressor every 2 minutes • If no advanced airway, 30:2 compression-ventilation ratio • Quantitative waveform capnography – If P_{ETCO_2} <10 mm Hg, attempt to improve CPR quality • Intra-arterial pressure – If relaxation phase (diastolic) pressure <20 mm Hg, attempt to improve CPR quality Return of Spontaneous Circulation (ROSC) • Pulse and blood pressure • Abrupt sustained increase in P_{ETCO_2} (typically ≥40 mm Hg) • Spontaneous arterial pressure waves with intra-arterial monitoring Shock Energy • Biphasic: Manufacturer recommendation (eg, initial dose of 120-200 J; if unknown, use maximum available. Second and subsequent doses should be equivalent, and higher doses may be considered. • Monophasic: 360 J Drug Therapy • Epinephrine IV/IO Dose: 1 mg every 3-5 minutes • Vasopressin IV/IO Dose: 40 units can replace first or second dose of epinephrine • Amiodarone IV/IO Dose: First dose: 300 mg bolus. Second dose: 150 mg. Advanced Airway • Supraglottic advanced airway or endotracheal intubation • Waveform capnography to confirm and monitor ET tube placement • 8-10 breaths per minute with continuous chest compressions Reversible Causes – Hypovolemia – Hypoxia – Hydrogen ion (acidosis) – Hypo-/hyperkalemia – Hypothermia – Tension pneumothorax – Tamponade, cardiac – Toxins – Thrombosis, pulmonary – Thrombosis, coronary															
9	Edukasi	Memberitahu keluarga mengenai kondisi pasien dan tindak lanjut dari tindakan yang telah dilakukan, serta meminta keluarga untuk tetap tenang pada kondisi tersebut.															
10	Prognosis	Dubia ad Malam															
11	Kompetensi	Semua dokter umum															
12	Indikator Medis	<table><tr><td>No</td><td>Konten</td><td>ya</td><td>tidak</td><td>keterangan</td></tr><tr><td>1.</td><td>Penegakan diagnosis</td><td>√</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.</td><td>Terapi</td><td>√</td><td></td><td></td></tr></table>	No	Konten	ya	tidak	keterangan	1.	Penegakan diagnosis	√			2.	Terapi	√		
No	Konten	ya	tidak	keterangan													
1.	Penegakan diagnosis	√															
2.	Terapi	√															
13	Kriteria Pasien Pulang	-															



	Rawat Inap	
14	Daftar Pustaka	1. Bigatello, L.M. et al. Adult and Pediatric Resuscitation in Critical Care Handbook of the Massachusetts General Hospital. 4Ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 2006. p: 255-279. (Bigatello, 2006) 2. O'Rourke. Walsh. Fuster. Hurst's The Heart Manual of Cardiology. 12th Ed. McGraw Hill. 2009. 3. Sudoyo, W. Aaru, B.S. Ilmu Penyakit Dalam Jilid III Edisi IV. Jakarta: FKUI. 2007. 4. American Heart Association. Buku Ajar ACLS. Perki Pusat. 2010



PANDUAN PRAKTIK KLINIS ANGINA PEKTORIS STABIL		
1	Pengertian	Angina pektoris stabil merupakan tanda klinis pertama pada sekitar 50% pasien yang mengalami penyakit jantung koroner. Angina pektoris dilaporkan terjadi dengan rata-rata kejadian 1,5% tergantung pada jenis kelamin, umur, dan faktor risiko. Data dari studi Framingham pada tahun 1970 menunjukkan prevalensi sekitar 1,5% untuk wanita dan 4,3% untuk pria berusia 50 – 59 tahun.
2	Anamnesis	Pasien datang dengan keluhan nyeri dada yang khas, yaitu seperti rasa ditekan atau terasa seperti ditimpa beban yang sangat berat. Diagnosis seringkali berdasarkan keluhan nyeri dada yang mempunyai ciri khas sebagai berikut: 1. Letak Sering pasien merasakan nyeri dada di daerah sternum atau di bawah sternum (substernal: tidak dapat melokalisasi), atau dada sebelah kiri dan kadang-kadang menjalar ke lengan kiri, dapat menjalar ke punggung, rahang, leher, atau ke lengan kanan. Nyeri dada juga dapat timbul di tempat lain seperti di daerah epigastrium, leher, rahang, gigi, dan bahu. 2. Kualitas Pada angina, nyeri dada biasanya seperti tertekan benda berat, atau seperti diperas atau terasa panas, kadang-kadang hanya mengeluh perasaan tidak enak di dada karena pasien tidak dapat menjelaskan dengan baik. 3. Hubungan dengan aktivitas Nyeri dada pada angina pektoris biasanya timbul pada saat melakukan aktivitas, misalnya sedang berjalan cepat, tergesa-gesa, atau sedang berjalan mendaki atau naik tangga. Pada kasus yang berat aktivitas ringan seperti mandi atau menggosok gigi, makan terlalu kenyang atau emosi, sudah dapat menimbulkan nyeri dada. Nyeri dada tersebut segera hilang bila pasien menghentikan aktivitasnya. Serangan angina yang timbul pada waktu istirahat atau pada waktu tidur malam sering akibat angina pektoris tidak stabil 4. Lamanya serangan Lamanya nyeri dada biasanya berlangsung 1-5 menit, kadang-kadang perasaan tidak enak di dada masih terasa setelah nyeri hilang. Bila nyeri dada berlangsung lebih dari 20 menit, mungkin pasien mengalami sindrom koroner akut dan bukan angina pektoris biasa. Pada angina pektoris dapat timbul keluhan lain seperti sesak napas, perasaan lelah, kadang-kadang nyeri dada disertai keringat dingin. Nyeri dada bisa disertai keringat dingin, mual, muntah, sesak dan pucat. Faktor Risiko



		Faktor risiko yang tidak dapat diubah: - Usia Risiko meningkat pada pria di atas 45 tahun dan wanita diatas 55 tahun (umumnya setelah menopause) - Jenis kelamin Morbiditas akibat penyakit jantung koroner (PJK) pada laki-laki dua kali lebih besar dibandingkan pada perempuan, hal ini berkaitan dengan estrogen endogen yang bersifat protektif pada perempuan. Hal ini terbukti insidensi PJK meningkat dengan cepat dan akhirnya setara dengan laki-laki pada wanita setelah masa menopause. Riwayat keluarga Riwayat keluarga PAK (Penyakit Arteri Koroner) dini yaitu ayah usia < 55 tahun dan ibu < 65 tahun. Faktor risiko yang dapat diubah: - Mayor - Peningkatan lipid serum - Hipertensi - Merokok - Konsumsi alkohol - Diabetes Melitus - Diet tinggi lemak jenuh, kolesterol dan kalori - Minor - Aktivitas fisik kurang - Stress psikologik - Tipe kepribadian
3	Pemeriksaan Fisik	- Sewaktu terjadi serangan angina dapat tidak menunjukkan kelainan. Walau jarang pada auskultasi dapat terdengar derap atrial atau ventrikel dan murmur sistolik di daerah apeks. Frekuensi denyut jantung dapat menurun, menetap atau meningkat pada waktu serangan angina. - Dapat ditemukan pembesaran jantung.
4	Pemeriksaan Penunjang	EKG Gambaran EKG saat istirahat dan bukan pada saat serangan angina sering masih normal. Gambaran EKG dapat menunjukkan bahwa pasien pernah mendapat infark miokard di masa lampau. Kadang-kadang menunjukkan pembesaran ventrikel kiri pada pasien hipertensi dan angina, dapat pula menunjukkan perubahan segmen ST atau gelombang T yang tidak khas. Pada saat serangan angina, EKG akan menunjukkan depresi segmen ST dan gelombang T dapat menjadi negatif. Gambaran EKG penderita angina tak stabil/ ATS dapat berupa depresi segmen ST, inversi gelombang T, depresi segmen ST disertai inversi gelombang T, elevasi segmen ST, hambatan cabang berkas His dan bisa tanpa perubahan segmen ST dan gelombang T. Perubahan



		EKG pada ATS bersifat sementara dan masing- masing dapat terjadi sendiri- sendiri ataupun bersamaan. Perubahan tersebut timbul di saat serangan angina dan kembali ke gambaran normal atau awal setelah keluhan angina hilang dalam waktu 24 jam. Bila perubahan tersebut menetap setelah 24 jam atau terjadi evolusi gelombang Q, maka disebut sebagai Infark Miokard Akut (IMA). 2. X ray thoraks X ray thoraks sering menunjukkan bentuk jantung yang normal. Pada pasien hipertensi dapat terlihat jantung membesar dan kadang-kadang tampak adanya kalsifikasi arkus aorta.
5	Kriteria Diagnosis	Diagnosis ditegakkan berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan penunjang. Klasifikasi Angina: 1. Stable Angina Pectoris (angina pectoris stabil) Keluhan nyeri dada timbul bila melakukan suatu pekerjaan, sesuai dengan berat ringannya pencetus, dibagi atas beberapa tingkatan: a. Selalu timbul sesudah latihan berat. b. Timbul sesudah latihan sedang (jalan cepat 1/2 km) c. Timbul waktu latihan ringan (jalan 100 m) d. Angina timbul jika gerak badan ringan (jalan biasa) 2. Unstable Angina Pectoris (angina pectoris tidak stabil/ATS) Angina dapat terjadi pada saat istirahat maupun bekerja. Pada patologi biasanya ditemukan daerah iskemik miokard yang mempunyai ciri tersendiri. 3. Angina Prinzmetal (Variant angina) Terjadi tanpa peningkatan jelas beban kerja jantung dan sering timbul pada waktu beristirahat atau tidur. Pada angina Prinzmetal terjadi spasme arteri koroner yang menimbulkan iskemi jantung di bagian hilir. Kadang-kadang tempat spasme berkaitan dengan arteriosklerosis. Klasifikasi Angina Pectoris menurut Canadian Cardiovascular Society Classification System: 1. Kelas I : Pada aktivitas fisik biasa tidak mencetuskan angina. Angina akan muncul ketika melakukan peningkatan aktivitas fisik (berjalan cepat, olahraga dalam waktu yang lama). 2. Kelas II : Adanya pembatasan aktivitas sedikit/aktivitas sehari- hari (naik tangga dengan cepat, jalan naik, jalan setelah makan, stres, dingin). 3. Kelas III : Benar-benar ada pembatasan aktivitas fisik karena sudah timbul gejala angina ketika pasien baru berjalan 1 blok atau naik tangga 1 tingkat. 4. Kelas IV : Tidak bisa melakukan aktivitas sehari-sehari, tidak nyaman, untuk melakukan aktivitas sedikit saja bisa kambuh, bahkan waktu istirahat juga bisa terjadi angina.
6	Diagnosis	Angina Pectoris Stabil



	Kerja						
7	Diagnosis Banding	Gastroesofageal Refluks Disease (GERD), Gastritis akut, Nyeri muskuloskeletal, Pleuritis, Herpes di dada, Trauma, Psikosomatik					
8	Terapi	Terapi farmakologi: 1. Oksigen dimulai 2 L/menit 2. Nitrat dikombinasikan dengan β -blocker atau Calcium Channel Blocker (CCB) non dihidropiridin yang tidak meningkatkan denyut jantung (misalnya verapamil, diltiazem). Pemberian dosis pada serangan akut: a. Nitrat 5 mg sublingual dapat dilanjutkan dengan 5 mg peroral sampai mendapat pelayanan rawat lanjutan di pelayanan sekunder. b. Beta bloker: Propanolol 20-80 mg dalam dosis terbagi atau Bisoprolol 2,5-5 mg per 24 jam. c. Calcium Channel Blocker (CCB) non dihidropiridine dipakai bila Beta Blocker merupakan kontraindikasi, misalnya: Verapamil 80 mg (2-3 kali sehari) dan Diltiazem 30 mg (3-4 kali sehari) 3. Antiplatelet Aspirin 160-320 mg sekali minum pada serangan akut.					
9	Edukasi	Menginformasikan individu dan keluarga untuk melakukan modifikasi gaya hidup antara lain: 1. Mengontrol emosi dan mengurangi kerja berat dimana membutuhkan banyak oksigen dalam aktivitasnya 2. Mengurangi konsumsi makanan berlemak 3. Menghentikan konsumsi rokok dan alkohol 4. Menjaga berat badan ideal 5. Mengatur pola makan 6. Melakukan olah raga ringan secara teratur 7. Jika memiliki riwayat diabetes tetap melakukan pengobatan diabetes secara teratur 8. Melakukan kontrol terhadap kadar serum lipid 9. Mengontrol tekanan darah					
10	Prognosis	Prognosis umumnya dubia ad bonam jika dilakukan tatalaksana dini dan tepat.					
11	Kompetensi	Semua dokter umum					
12	Indikator Medis	No	Konten	ya	tidak	keterangan	
		1.	Penegakan diagnosis	√			
		2.	Terapi	√			
13	Kriteria Pasien Pulang Rawat Inap	Jika Sudah Tidak Nyeri Dada Hemodinamik stabil ECG Ulang Normal					
14	Daftar Pustaka	1. Isselbacher, J Kurt. Harrison Prinsip-Prinsip Ilmu Penyakit Dalam Edisi 13 Volume 3. Jakarta: EGC. 2000. (Isselbacher, 2000)					



		2. O'Rourke., Walsh., Fuster. Hurst's The Heart Manual of Cardiology.12th Ed. McGraw-Hill. 2009. (O'Rourke, et al., 2009) 3. Priori, S. G., Blanc, J. J., (France), Budaj., A., Camm, J., Dean, V., Deckers, J., Dickstein. K., Lekakis, J., McGregor. K., Metra. M., Morais. J., Osterspey. A., Tamargo, J., Zamorano, J. L., Guidelines on the management of stable angina pectoris, 2006, European Heart Journal doi:10.1093/eurheartj/ehl002 ESC Committee for Practice Guidelines (CPG). (Priori, et al., 2006) 5. Sudoyo, W. Aaru, Bambang Setiyohadi. Ilmu Penyakit Dalam Jilid III Edisi IV. Jakarta: FKUI.2007.c (Sudoyo, et al., 2006)
--	--	--

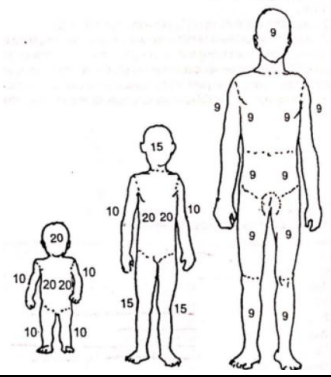


PANDUAN PRAKTIK KLINIS SERANGAN ASMA																																																									
1	Pengertian	Episode perburukan gejala yang progresif dari sesak, batuk, mengi, atau rasa berat di dada, atau kombinasi gejala-gejala tersebut.																																																							
2	Anamnesis	1. Sesak napas yang episodik. 2. Batuk-batuk berdahak yang sering memburuk pada malam dan pagi hari menjelang subuh, lebih sering kronis. 3. Mengi																																																							
3	Pemeriksaan Fisik	1. Kedaan umum: tampak sesak napas 2. Tanda-tanda vital 3. Pemeriksaan fisik thorax: Terdengar wheezing pada auskultasi thorax. Pada serangan berat digunakan otot bantu napas (retraksi supraklavikula, interkostal, dan epigastrium).																																																							
4	Pemeriksaan Penunjang	1. Arus Puncak Ekspirasi (APE) menggunakan Peak Flowmeter 2. Pemeriksaan darah (eosinofil dalam darah)																																																							
5	Kriteria Diagnosis	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Gejala dan tanda</th><th colspan="3">Berat serangan akut</th><th rowspan="2">Keadaan mengancam jiwa</th></tr> <tr> <th>Ringan</th><th>Sedang</th><th>Berat</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sesak napas</td><td>Berjalan</td><td>Berbicara</td><td>Istirahat</td><td></td></tr> <tr> <td>Posisi</td><td>Dapat tidur telentang</td><td>Membungkuk</td><td>Duduk membungkuk</td><td></td></tr> <tr> <td>Cara bicara</td><td>Satu kalimat</td><td>Beberapa kata</td><td>Kata demi kata</td><td></td></tr> <tr> <td>Kesadaran</td><td>Mungkin gelisah</td><td>Gelisah</td><td>Gelisah</td><td>Mengantuk, gelisah, kesadaran menurun</td></tr> <tr> <td>Frekuensi napas</td><td>< 20/menit</td><td>20-30/menit</td><td>>30/menit</td><td></td></tr> <tr> <td>Nadi</td><td><100</td><td>100-120</td><td>>120</td><td>Bradikardia</td></tr> <tr> <td>Pulsus Paradoksus</td><td>- 10 mmHg</td><td>+/- 10-20 mmHg</td><td>+ > 25 mmHg</td><td>Kelelahan otot</td></tr> <tr> <td>Otot bantu napas dan retraksi</td><td>-</td><td>+</td><td>+</td><td>Torakoabdominal paradoksial</td></tr> <tr> <td>Mengi</td><td>Akhir ekspirasi paksa</td><td>Akhir ekspirasi</td><td>Inspirasi dan ekspirasi</td><td>Silent chest</td></tr> </tbody> </table>			Gejala dan tanda	Berat serangan akut			Keadaan mengancam jiwa	Ringan	Sedang	Berat	Sesak napas	Berjalan	Berbicara	Istirahat		Posisi	Dapat tidur telentang	Membungkuk	Duduk membungkuk		Cara bicara	Satu kalimat	Beberapa kata	Kata demi kata		Kesadaran	Mungkin gelisah	Gelisah	Gelisah	Mengantuk, gelisah, kesadaran menurun	Frekuensi napas	< 20/menit	20-30/menit	>30/menit		Nadi	<100	100-120	>120	Bradikardia	Pulsus Paradoksus	- 10 mmHg	+/- 10-20 mmHg	+ > 25 mmHg	Kelelahan otot	Otot bantu napas dan retraksi	-	+	+	Torakoabdominal paradoksial	Mengi	Akhir ekspirasi paksa	Akhir ekspirasi	Inspirasi dan ekspirasi	Silent chest
Gejala dan tanda	Berat serangan akut			Keadaan mengancam jiwa																																																					
	Ringan	Sedang	Berat																																																						
Sesak napas	Berjalan	Berbicara	Istirahat																																																						
Posisi	Dapat tidur telentang	Membungkuk	Duduk membungkuk																																																						
Cara bicara	Satu kalimat	Beberapa kata	Kata demi kata																																																						
Kesadaran	Mungkin gelisah	Gelisah	Gelisah	Mengantuk, gelisah, kesadaran menurun																																																					
Frekuensi napas	< 20/menit	20-30/menit	>30/menit																																																						
Nadi	<100	100-120	>120	Bradikardia																																																					
Pulsus Paradoksus	- 10 mmHg	+/- 10-20 mmHg	+ > 25 mmHg	Kelelahan otot																																																					
Otot bantu napas dan retraksi	-	+	+	Torakoabdominal paradoksial																																																					
Mengi	Akhir ekspirasi paksa	Akhir ekspirasi	Inspirasi dan ekspirasi	Silent chest																																																					
6	Diagnosis Kerja	Serangan Asma																																																							
7	Diagnosis Banding	Obstruksi jalan napas, Bronkitis kronik, Bronkiektasis.																																																							
8	Terapi	1. Serangan Ringan Inhalasi agonis β -2 kerja singkat tunggal (misal: salbutamol) atau dikombinasikan dengan antikolinergik (misal: ipratropium bromide). Alternatif: kombinasi oral agonis β -2 (salbutamol 0.05-0.1 mg/kgBB/kali setiap 6-8 jam) dan aminofilin 3 - 4 x 100-300 mg.																																																							



		2.Serangan Sedang a. Oksigenasi b. Nebulasi agonis β -2 tiap 4 jam. Alternatif: agonis β -2 subkutan, aminofilin IV, adrenalin 1/1000 0,3ml subcutan. a. Kortikosteroid sistemik Budesonide 200-1200 mcg perhari, terbagi ke dalam 2-4 pemberian. Dosis pemeliharaan 200-400 mcg dua kali sehari pagi dan malam, dapat ditingkatkan hingga 1200 mcg pada asma berat. 3. Serangan Berat a. Oksigenasi b. Nebulasi agonis β -2 tiap 4 jam. Alternatif: agonis β -2 subkutan/ IV, adrenalin 1/1000 0,3ml subcutan. a. Aminofilin bolus lanjut drip (dosis awal 6-8 mg/kgBB, dilanjutkan rumatan 0.5-1 mg/kgBB/jam) b. Kortikosteroid IV					
9	Edukasi	1. Pola hidup sehat; 2. Menghindari pencetus; 3. Menggunakan bronkodilator/steroid					
10	Prognosis	Ad vitam : ad bonam Ad functionam : ad bonam Ad sanationam: ad bonam					
11	Kompetensi	Semua dokter umum					
13	Indikator Medis	No	Konten	Ya	Tidak	Keterangan	
		1	Penegakan Diagnosis	√			
		3	Teapi	√			
14	Kriteria Pulang	1. Bila terjadi perbaikan klinis, yaitu 2. keluhan berkurang 3. frekuensi napas kembali normal 4. mengi menghilang 5. pasien dapat bernapas tanpa otot-otot bantu napas					
15	Daftar Pustaka	Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Asma. Pedoman Diagnosis dan Penatalaksanaan di Indonesia. PDPI. Jakarta. 2004. Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention. GINA. 2012.					



PANDUAN PRAKTIK KLINIS LUKA BAKAR		
1	Pengertian	Rusak atau hilangnya jaringan yang disebabkan kontak dengan sumber panas seperti kobaran api di tubuh (flame), jilatan api ketubuh (flash), terkena air panas (scald), tersentuh benda panas (kontak panas), akibat sengatan listrik, akibat bahan-bahan kimia, serta sengatan matahari (sunburn)
2	Anamnesis	Luka akibat suhu panas, listrik, sinar matahari, kimia ataupun radiasi. Pada luka bakar derajat I kulit terasa nyeri dan kemerahan. Pada luka bakar derajat II timbul nyeri dan bulae. Pada luka bakar derajat III timbul nyeri, luka bakar berat dan luas.
3	Pemeriksaan Fisik	1. Kulit mengelupas 2. Kulit melepuh 3. Luka melepuh 4. Kulit hangus 5. Tanda dehidrasi
4	Pemeriksaan Penunjang	1. Darah lengkap 2. Urine lengkap 3. Elektrolit
5	Kriteria Diagnosis	1. Luka bakar derajat I, kerusakan terbatas pada lapisan epidermis (superficial), kulit hiperemi berupa eritema, perabaan hangat, tidak dijumpai bulla, terasa nyeri karena ujung-ujung saraf sensorik teriritasi. 2. Luka bakar derajat II, Kerusakan meliputi epidermis dan sebagian dermis, berupa reaksi inflamasi disertai proses eksudasi. Terdapat bullae dan nyeri karena ujung-ujung saraf sensorik yang teriritasi. 3. Luka bakar derajat III, kerusakan mengenai seluruh lapisan epidermis dan dermis. Luka tampak kering dan koagulasi pada permukaan kulit . Dehidrasi, nyeri, cemas. 4. Luas luka bakar 
6	Diagnosis Kerja	Luka bakar
7	Diagnosis	Cold Injury



	Banding	
8	Terapi	1. Tindakan darurat ABC 2. Terapi cairan Pada pasien anak dengan luas luka > 10%, dewasa dengan luas luka > 15% 8 jam pertama $\frac{1}{2}$ (4cc x KgBB x % luas luka bakar) Ringer Lactat 16 jam berikutnya $\frac{1}{2}$ (4cc x Kg x % luas luka bakar) Ringer Lactat 3. Analgetik Ketorolac 3 x 30mg 4. Perawatan Luka : a. Bersihkan luka bakar b. Perawatan tertutup : Setelah luka bersih, ditutup dengan selapis kain steril berlubang – lubang (tulle) yang mengandung vaselin dengan atau tanpa antibiotika lalu dibebat tebal untuk mencegah evaporasi dan melindungi kulit dari trauma dan bakteri. Sendi – sendi ditempatkan pada posisi <i>full extension</i>. c. Perawatan terbuka : Eksudat yang keluar dari luka beserta debris akan mengering akan menjadi lapisan eschar. Penyembuhan akan berlangsung dibawah eschar. Penderita dirawat di dalam ruangan isolasi. Setiap eschar yang pecah harus diberikan obat – obatan lokal dan dikontrol bila ada penumpukan pus dibawah eschar maka harus dilakukan pemupukan eschar (escharotomi). 5. Obat topikal : Silver sulfadiazin krim 1% diberikan sehari sekali. Silver sulfadiazin bekerja sebagai bakterisida yang efektif terhadap kuman gram positif 6. Antibiotika sistemik Antibiotika broad spectrum, misal ceftriaxon 20-50 mg/kg berat badan (BB) satu kali sehari atau meropenem 10 - 20 mg/kgBB setiap 8 jam.
9	Edukasi	1. Edukasi tentang penyakit yang diderita dan komplikasi yang mungkin akan dihadapi 2. Luka jangan terkena air. 3. Edukasi bahwa sesudah luka kering (epitelisasi) proses penyembuhan luka belum selesai. Masih terdapat kemungkinan terjadi kontraktur hingga 6 – 12 bulan sesudah luka epitelisasi. Untuk mencegah terjadinya kontraktur, diperlukan terapi pressure garment dan terapi lainnya.
10	Prognosis	Ad vitam : luka bakar derajat I ad bonam, luka bakar derajat II-III dubia Ad sanationam : luka bakar derajat I ad bonam, luka bakar derajat II-III dubia



		Ad fungsionam : luka bakar derajat I ad bonam, luka bakar derajat II-III dubia				
11	Kompetensi	luka bakar derajat I-II: 4A luka bakar derajat III: 3B				
12	Indikator Medis	No	Konten	Ya	Tidak	Keterangan
		1	Penegakan Diagnosis	√		
		3	Terapi	√		
13	Kriteria Pasien Pulang	Tidak termasuk salah satu dari kriteria: 1. Penderita syok atau terancam syok (anak: luas luka > 10%, dewasa: luas luka > 15%) 2. Letak luka memungkinkan pasien mengalami cacat berat (wajah, mata, tangan dan kaki, perineum) 3. Terancam trauma inhalasi.				
14	Daftar Pustaka	Sjamsuhidajat. de Jong. Luka bakar. Buku Kedokteran EGC. 2007: Hal: 103-110.				



PENUTUP

Dengan telah tersusunnya Panduan Praktik Klinis ini diharapkan dapat menjadi Standar Prosedur Operasional bagi dokter Umum yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Dokter Umum dan fasilitas pelayanan kesehatan di RSI Sultan Agung.

Melalui panduan ini diharapkan terselenggara pelayanan medis yang efektif, efisien, bermutu dan merata sesuai sumber daya, fasilitas, pra fasilitas, dana dan prosedur serta metode yang memadai, semoga bermanfaat.

DIREKTUR UTAMA

RUMAH SAKIT ISLAM SULTAN AGUNG

YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
 **RSI SULTAN
AGUNG**
ISLAMIC TEACHING HOSPITAL
Dr. H. MASYHUDI AM, M.Kes.
SEMARANG - JAWA TENGAH